

CAPÍTULO 7.9

Hipertiroidismo

PERFIL EUNACOM 1.03.1.007

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Insuficiencia Suprarrenal

Causas

TABLA 7.9.1: TIPO VS CAUSA			
TIPO	CAUSA	ACTH	ALDOSTERONA
Primaria (Addison)	Adrenalitis autoinmune (más frecuente actualmente), TBC	↑↑	↓
Secundaria (hipofisaria)	Hipopituitarismo	↓	Normal o ↑

NOTA CLÍNICA

Antes la TBC era la causa #1. Ahora es la **adrenalitis autoinmune**.

Clínica

Síntomas generales (cualquier tipo)

- **Astenia** (más frecuente) - Náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea - Hipotensión

Específico de la insuficiencia primaria

- **Hiperpigmentación** (melanoplaques en mucosa oral, palmas, genitales) - Mecanismo: ↑ ACTH → se libera junto con MSH → estimula melanocitos

Exámenes orientadores

TABLA 7.9.2: EXAMEN VS HALLAZGO	
EXAMEN	HALLAZGO
Sodio	Hiponatremia
Potasio	Hipercalemia
Glicemia	Hipoglicemia
Calcio	Hipercalcemia (a veces)
pH	Acidosis metabólica leve
Leucocitos	Leucocitosis con eosinofilia

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Triada de laboratorio de insuficiencia suprarrenal: Hiponatremia + Hipercalemia + Hipoglicemia. Es la **inversa** del Cushing (que presenta hipokalemia, hiperglicemia, alcalosis).

Diagnóstico

Prueba de estimulación con ACTH (cosintropina)

No confundir con la **prueba de supresión con dexametasona** del Cushing → son distintas.

TABLA 7.9.3: RESULTADO VS INTERPRETACIÓN	
RESULTADO	INTERPRETACIÓN
Cortisol basal muy bajo (< 80 nmol/L)	Diagnóstico confirmado sin necesidad de estimulación
Cortisol basal bajo-normal (< 500 nmol/L)	Estimular con ACTH → si no sube > 500 nmol/L → insuf. suprarrenal

Diferencias primaria vs. secundaria

TABLA 7.9.4: PARÁMETRO VS PRIMARIA		
PARÁMETRO	PRIMARIA	SECUNDARIA
ACTH	↑↑	↓
Aldosterona	↓	Normal/↑
Hiperpigmentación	Sí	No

Tratamiento Crónico

TABLA 7.9.5: TIPO VS TRATAMIENTO	
TIPO	TRATAMIENTO
Primaria	Hidrocortisona VO + Fludrocortisona (mineralocorticoide)
Secundaria	Solo Hidrocortisona VO

EUNACOM CRITERIOS

Fludrocortisona (análogo de aldosterona) se agrega **solo** en la insuficiencia suprarrenal **primaria** porque en la secundaria, la función mineralocorticoide de las suprarrenales está preservada.

- En situaciones de **estrés** (infección, cirugía, trauma) → **aumentar el doble la dosis de hidrocortisona** de forma preventiva

Crisis Suprarrenal Aguda

Cuadro clínico

- Paciente en shock que **no responde a volumen**
- Hipotensión refractaria a drogas vasoactivas
- Hiponatremia + Hipercalemia + Hipoglicemia
- Puede confundirse con shock séptico o cardiogénico

Antecedentes que hacen sospecharla

- Uso crónico de corticoides orales (suspendidos bruscamente)
- Diagnóstico previo de Addison o hipopituitarismo
- Hiperpigmentación en el examen
- Hiperplasia suprarrenal congénita
- VIH (adrenalitis por CMV)
- Meningococcemia → **síndrome de Waterhouse-Friderichsen** (infarto bilateral hemorrágico de las suprarrenales)

Tratamiento — Ante la mera sospecha clínica

- Suero fisiológico EV** (reponer volemia)
- Hidrocortisona EV** → **inmediatamente** (no esperar exámenes confirmatorios)
- Corregir hipoglicemia (glucosa hipertónica EV)
- Buscar y tratar el desencadenante (infección, discontinuación de corticoides, etc.)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

No perder tiempo en pruebas diagnósticas. Ante sospecha de crisis suprarrenal → dar hidrocortisona EV de inmediato. El paciente puede morir si se esperan resultados. Si se puede, extraer cortisol basal antes del tratamiento, pero no es indispensable.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Mujer de 32 años consulta por pérdida de 6 kg de peso en 2 meses con apetito aumentado, temblor distal fino, palpitaciones, intolerancia al calor y diarrea. Al examen: FC 115 lpm regular, bocio difuso con soplo auscultatorio tiroideo, exoftalmos bilateral y retracción palpebral. TSH < 0.01 mUI/L, T4 libre 3.8 ng/dL."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Hipertiroidismo por Enfermedad de Basedow-Graves: causa más frecuente de tirotoxicosis en mujeres jóvenes. Tríada: Bocio difuso + Oftalmopatía infiltrativa (exoftalmos) + Dermopatía (mixedema pretibial). Anticuerpos anti-receptor de TSH (TRAb) positivos. Tratamiento: Betabloqueadores (Propranolol) para control sintomático + Antitiroideos de síntesis (Metimazol como primera línea; Propiltiouracilo en 1er trimestre de embarazo).

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Clínica: síntomas B (hipercatabolismo), intolerancia al calor, taquicardia, temblor, nerviosismo, hiperreflexia.
- No confundir mirada expresiva/signo de Graefe (todo hipertiroidismo) con exoftalmo (solo Basedow-Graves).
- Basedow-Graves: bocio difuso + exoftalmo + mixedema pretibial. Diagnóstico con TRAB positivos.
- Cintigrafía: captación difusa = Graves, nódulo caliente = adenoma tóxico, sin captación = tiroiditis.
- Tratamiento: betabloqueantes + metimazol (1ª línea). En embarazo: PTU de elección.
- Seguimiento con T4 libre (no TSH). Diferencia con hipotiroidismo que se sigue con TSH.
- Tiroglobulina elevada + captación baja = tiroiditis. Tiroglobulina baja + captación baja = T4 exógena.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (HIPERTIROIDISMO)**PREGUNTA 1**

Mujer de 25 años con palpitaciones, baja de peso, nerviosismo. Examen: bocio difuso, exoftalmo bilateral, TSH <0,01 mU/L, T4 libre 3,8 ng/dL. ¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento de primera línea?

- A)** Adenoma tóxico - Tiroidectomía
- B)** Enfermedad de Basedow-Graves - Metimazol + betabloqueante
- C)** Tiroiditis subaguda - AINEs
- D)** Basedow-Graves - Yodo radioactivo de entrada
- E)** Basedow-Graves - PTU

PREGUNTA 2

Embarazada de 14 semanas diagnosticada con hipertiroidismo por Basedow-Graves. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

- A)** Metimazol
- B)** Propiltiouracilo (PTU)
- C)** Propranolol
- D)** Yodo radioactivo
- E)** Tiroidectomía total

RESUMEN: HIPERTIROIDISMO

El hipertiroidismo presenta astenia, síntomas B (fiebre, baja de peso, sudoración nocturna), intolerancia al calor, polidefecación/diarrea, piel húmeda, síntomas hiperadrenérgicos (nerviosismo, palpitaciones, temblor), mirada expresiva con signo de Graefe, taquicardia, hipertermia e hiperreflexia. No confundir la mirada expresiva/Graefe (hiperadrenergia, en todo hipertiroidismo) con el exoftalmo (propio de Basedow-Graves). La enfermedad de Basedow-Graves es la causa más frecuente, con diagnóstico clínico: bocio difuso (puede tener soplo tiroideo), exoftalmo/orbitopatía distiroidea y mixedema pretibial. Diagnóstico etiológico con TRAB (anticuerpos anti-receptor de TSH, diagnósticos de Basedow-Graves) y cintigrafía con yodo radioactivo. Tratamiento: betabloqueantes para síntomas + antitiroideos (metimazol de elección). Tiroidectomía de segunda línea. En embarazo: PTU de elección. Seguimiento con T4 libre (no TSH). Casos especiales: tiroglobulina muy elevada + captación disminuida = tiroiditis subaguda. Tiroglobulina disminuida + captación disminuida = T4 exógena (trastorno facticio).